LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

SISTEM INFORMASI BASIS DATA DALAM PENGELOLAAN JADWAL PRAKTEK DOKTER BERDASARKAN KLINIK SPESIALISASI DI RUMAH SAKIT PONDOK INDAH - PURI INDAH

Disusun oleh :

32230112 - Fricilia Angelica

32230116 - Devin Alfred Taniaga

32230127 - Daniel Herdjanto

32230137 - Timothy Antonio

Nama Dosen Pengampu:

Agustinus Fritz Wijaya, S.Kom., M.Cs.

Mata Kuliah:

Sistem Basis Data - SIE04

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN

UNIVERSITAS BUNDA MULIA

JAKARTA

2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang……2

1.2. Batasan Masalah…….3

1.3. Tujuan…….3

BAB II LANDASAN TEORI……..5

BAB III ANALISIS KEBUTUHAN……...7

3.1. Deskripsi Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah……7

3.2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah……...10

3.3. Daftar Pertanyaan Wawancara……...11

3.4. Analisis Permasalahan……...12

BAB IV RANCANGAN DATABASE……...13

4.1. Entity Relationship Diagram……13

4.2. Struktur Table……13

4.3. Query SQL……14

BAB V PENUTUP……..16

5.1. Kesimpulan……16

5.2. Penutup……..16

DAFTAR PUSTAKA……..17

DAFTAR GAMBAR……..18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), rumah sakit adalah gedung tempat menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan. Untuk menyediakan pelayanan kesehatan, dibutuhkan dokter untuk menangani berbagai masalah kesehatan dari masalah kesehatan yang ringan seperti batuk-pilek, vaksinasi, hingga masalah kesehatan yang besar, seperti operasi organ tubuh inti seperti jantung dan paru-paru.

Untuk menyediakan semua layanan kesehatan, tidaklah cukup dilayani oleh 1 orang dokter saja, tetapi butuh dilayani banyak dokter dengan spesialisasi masing-masing sesuai dengan keahliannya. Di dalam RSPI (Rumah Sakit Pondok Indah), terdapat banyak dokter dengan berbagai spesialisasi, dan akan sangat sulit mendata dokter yang ada apabila daftar dokter di data satu-persatu secara manual, apalagi dengan metode lama yaitu hanya dengan menuliskan pada satu tempat, misalnya hanya pada 1 buku, dan harus diakses oleh semua elemen di rumah sakit termasuk *owner* rumah sakit beserta jajarannya, sedangkan di rumah sakit seperti RSPI ini bukan sebuah rumah sakit yang berskala kecil, sehingga akan merepotkan satu sama lain dan sangat tidak efektif apabila hanya memiliki satu cara, lebih-lebih lagi apabila menggunakan buku seperti metode rumah sakit tradisional. Lalu, sistem manual tidak hanya memperlambat akses dan pembaruan data, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan dan keterlambatan informasi yang dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada pasien.

Oleh karena itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi menjadi krusial dalam mempermudah pengelolaan data dokter. Sistem manajemen dokter berbasis digital dapat menyediakan akses yang cepat dan akurat, memungkinkan semua elemen rumah sakit dapat mengakses informasi yang diperlukan secara real-time. Dengan sistem ini, data dokter bisa dikelola lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta memastikan bahwa

setiap bagian rumah sakit dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa hambatan administratif yang berlebihan.

1.2. Batasan Masalah

Dalam pengambilan dan pendataan pada data dokter di RSPI, terdapat beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Lingkup Data Dokter

   Sistem ini hanya akan mendata informasi dokter yang mencakup nama dokter, spesialisasi dokter, ID dokter, ID klinik, jadwal dan hari praktek. Data lain yang bersifat administratif, seperti gaji, data pribadi seperti alamat dan kontak, dan nomor izin praktek, tidak termasuk dalam pengembangan sistem ini.
2. Integrasi dengan Sistem Lain

   Database ini dibuat sedemikian rupa agar dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem lain, sehingga memungkinkan pertukaran data yang efisien dan aman antara berbagai sistem, dan mendukung kolaborasi antar departemen dalam rumah sakit secara optimal.
3. Pengelolaan Jadwal Dokter

   Sistem ini hanya akan mencakup jadwal dokter secara umum. Fungsi untuk mencatat praktek dokter di luar jadwal, seperti melalui perjanjian, tidak akan dimasukkan dalam pengembangan tahap awal.

1.3. Tujuan

Tujuan dilakukannya digitalisasi dalam sistem basis data RSPI, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan data dokter, dengan membangun sistem yang dapat mengelola data dokter secara digital untuk memudahkan proses pencatatan, pembaharuan, dan pencarian informasi terkait identitas, spesialisasi, serta jadwal praktek dokter secara cepat dan akurat. Kemudian digitalisasi sistem basis data juga dapat memfasilitasi akses data yang cepat dan tepat, dapat menyediakan akses data dokter yang lebih mudah dan terstruktur bagi berbagai pihak di rumah sakit, sehingga mempercepat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Lalu dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data yang sering terjadi pada sistem manual dengan beralih ke sistem digital yang lebih aman, andal, dan terotomatisasi.

BAB II
LANDASAN TEORI

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data rumah sakit secara terintegrasi. Tujuannya adalah untuk membantu operasional rumah sakit dalam hal manajemen pasien, rekam medis, sumber daya manusia, keuangan, serta jadwal dokter. SIMRS memungkinkan akses real-time terhadap data penting rumah sakit, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Integrasi data yang efektif dapat mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses administrasi, serta memberikan akses mudah bagi manajemen dan staf medis.

Database Relasional dalam Pengelolaan Data Medis

Database relasional merupakan salah satu jenis database yang menggunakan tabel-tabel terkait untuk menyimpan data. Dalam konteks rumah sakit, database relasional sangat cocok digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dokter karena strukturnya yang terorganisir dengan baik dan kemampuan untuk melakukan pencarian data dengan efisien. Sistem manajemen basis data (DBMS) yang baik memungkinkan pengelolaan data dokter yang lebih mudah, termasuk penambahan, penghapusan, dan pembaruan data.

Pengelolaan Data Dokter dan Interoperabilitas Sistem Kesehatan

Dalam lingkungan rumah sakit modern, interoperabilitas antar sistem sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi. Pengelolaan data dokter yang terstruktur dan berbasis teknologi informasi memungkinkan rumah sakit untuk mengintegrasikan sistem lain seperti rekam medis elektronik (Electronic Medical Record, EMR) dan sistem informasi klinis. Hal ini dapat mendukung proses pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat, serta memperbaiki alur kerja di rumah sakit. Standar protokol seperti HL7 (Health Level 7) dan FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) digunakan untuk memastikan data dapat ditransfer antar sistem secara aman dan konsisten.

Keamanan Data dalam Sistem Informasi Kesehatan

Pengelolaan data dokter dalam sistem informasi rumah sakit harus memperhatikan aspek keamanan data. Mengingat sifat sensitif data medis, langkah-langkah pengamanan seperti enkripsi data, otentikasi berbasis peran (role-based access), dan penggunaan firewall menjadi krusial dalam memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia juga mengatur keamanan data pribadi, termasuk dalam sektor kesehatan, sehingga implementasi sistem informasi harus memenuhi ketentuan hukum tersebut.

Efisiensi Operasional Rumah Sakit melalui Sistem Digital

Digitalisasi proses di rumah sakit, termasuk dalam pengelolaan data dokter, memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi operasional. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang baik dapat mengurangi waktu administrasi, meningkatkan akurasi data, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan rumah sakit untuk memproses informasi dalam skala besar secara cepat dan dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah.

BAB III
ANALISIS KEBUTUHAN

3.1. Deskripsi Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah

Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah merupakan salah satu rumah sakit swasta modern yang dioperasikan oleh Rumah Sakit Pondok Indah Group. Rumah sakit yang dipimpin oleh dr. Yanwar Hadiyanto, MARS sebagai CEO ini merupakan rumah sakit kedua yang didirikan oleh Rumah Sakit Pondok Indah Group, setelah Rumah Sakit Pondok Indah – Pondok Indah. Resmi beroperasi sejak 12 Mei 2008, Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan berstandar internasional di kawasan Jakarta Barat. Rumah sakit ini terletak di Jl. Puri Indah Raya Blok S-2, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini berlokasi strategis di pusat kawasan perumahan dan komersial Puri Indah.

Sebagai rumah sakit kedua yang didirikan oleh Rumah Sakit Pondok Indah Group, Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah menawarkan konsep pelayanan kesehatan terintegrasi yang mencakup rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, hingga layanan diagnostik canggih. Didukung oleh teknologi medis terkini, fasilitas yang lengkap, serta tim medis yang berkompeten, Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah berkomitmen untuk memberikan perawatan terbaik kepada setiap pasien. Hal ini sejalan dengan visi Rumah Sakit Pondok Indah Group, yaitu “menjadi rumah sakit pilihan dengan menyediakan layanan perawatan kesehatan terbaik, aman, bermutu tinggi, dan inovatif.”

RUMAH SAKIT
PONDOK INDAH
GROUP

Gambar 3.1 Logo Rumah Sakit Pondok Indah Group

Rumah Sakit Pondok Indah Group juga memiliki misi untuk "menyediakan pelayanan secara utuh, konsisten dan terpadu berfokus pada pasien melalui praktik berbasis bukti yang sesuai dan pelayanan prima dengan komitmen, kerja sama tim, keterlibatan dari pihak terkait dan peningkatan kompetensi individu yang berkesinambungan". Tidak hanya berfokus pada pelayanan perawatan pasien, Rumah Sakit Pondok Indah Group juga turut berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang berpegang pada 4 (empat) pilar, yaitu kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan bantuan sosial. Adapun nilai-nilai yang dianut oleh Rumah Sakit Pondok Indah Group adalah integritas, kualitas, kerjasama tim, etika, semangat & ketangguhan, inovasi, pengembangan individu, serta pembelajaran berkesinambungan.

Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah berdiri diatas lahan seluas 7.000 meter persegi dan area bangunan seluas 31.150 meter persegi. Sebagai rumah sakit dengan konsep "*one-stop healthcare service*", Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah menawarkan layanan medis yang komprehensif, mulai dari rawat jalan, rawat inap, hingga layanan diagnostik dan terapi. Didukung oleh tim dokter spesialis dan subspesialis yang berpengalaman, rumah sakit ini menangani berbagai kebutuhan medis, termasuk bidang kardiologi, onkologi, ortopedi, pediatri, dan kesehatan wanita.

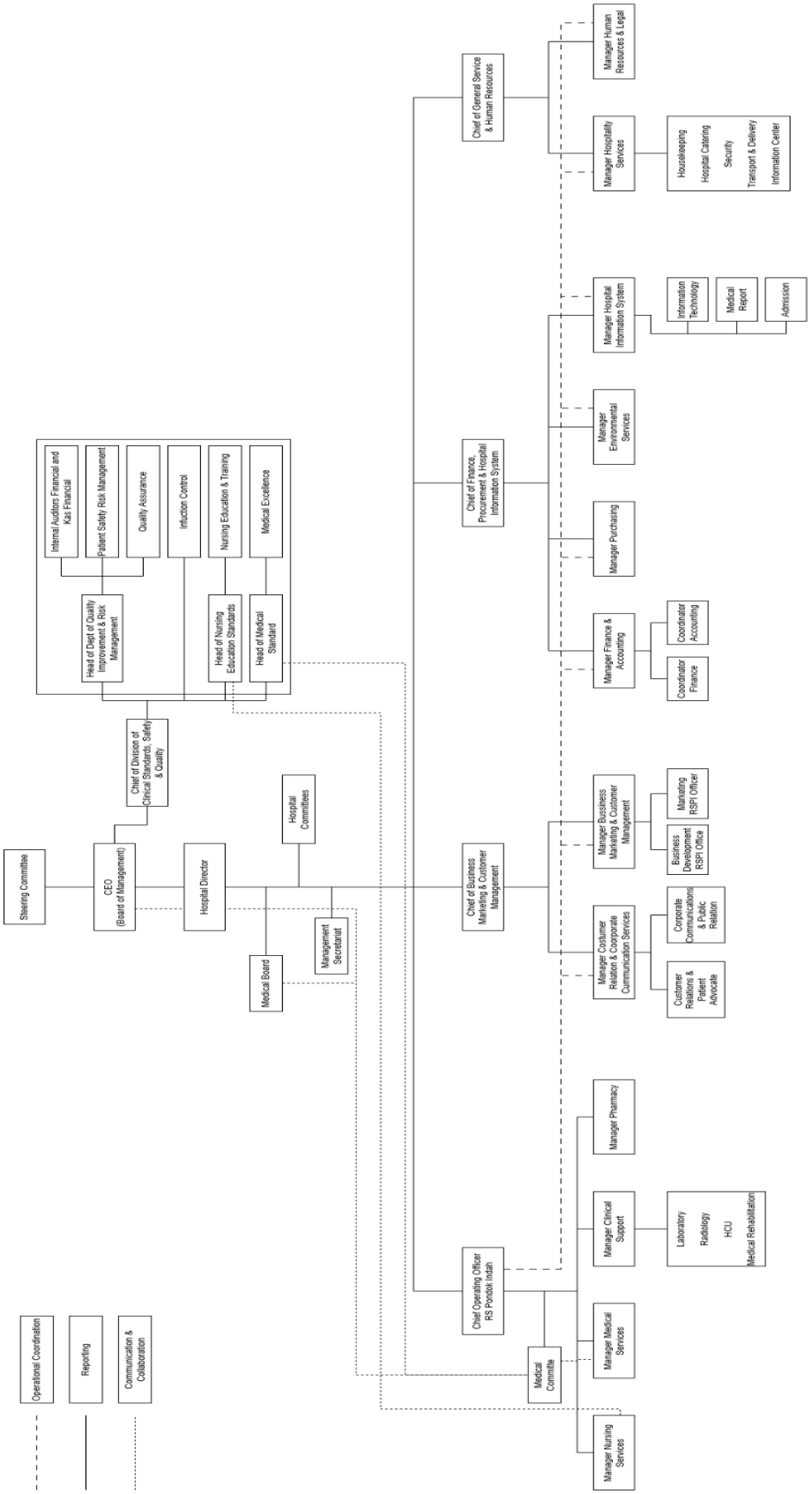
Gambar 3.2 Bangunan Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah

Rumah sakit ini juga dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti MRI 3 Tesla, CT scan multi-slice, laboratorium terpadu, dan pusat rehabilitasi medik. Pelayanan pasien dirancang dengan konsep "*healing environment*" yang ramah lingkungan dan profesional untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pasien selama masa perawatan.

Sebagai bagian dari inisiatif digitalisasi, Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah telah mengadopsi *Electronic Medical Records* (EMR) untuk mengintegrasikan semua data medis pasien secara real-time. Digitalisasi juga diterapkan dalam layanan penjadwalan, konsultasi, dan rujukan, yang mempermudah pasien dalam mengakses layanan kesehatan. Dengan inovasi ini, Rumah Sakit Pondok Indah Group telah meraih penghargaan sebagai *Best Information and Technology System Excellence* dari Majalah SWA.

Dengan fasilitas modern, layanan kesehatan unggulan, serta penghargaan yang telah diraih, Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah terus berupaya menjadi rumah sakit pilihan bagi masyarakat Indonesia dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup melalui layanan kesehatan bermutu tinggi.

3.2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah

3.3. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Di bawah naungan institusi atau grup manakah Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah beroperasi?
2. Apa tujuan utama pendirian Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah?
3. Siapakah CEO yang memimpin Rumah Sakit Pondok Indah Group?
4. Siapakah Direktur Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah?
5. Kapan Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah resmi beroperasi?
6. Berapa luas lahan dan bangunan dari Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah?
7. Apa visi dan misi dari Rumah Sakit Pondok Indah Group?
8. Layanan medis apa saja yang menjadi unggulan di Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah?
9. Konsep apa yang diterapkan oleh Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah?
10. Adakah penghargaan yang telah diraih Rumah Sakit Pondok Indah Group terkait teknologi informasi?
11. Bagaimana Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
12. Bagaimana susunan struktur organisasi yang ada di Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah?
13. Apakah Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah ini melayani pasien yang menggunakan BPJS?
14. Apakah ada perbedaan jadwal pelayanan antara pasien reguler dan pasien BPJS?
15. Ada berapa banyak klinik atau spesialis yang tersedia di Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah ini?
16. Apakah klinik atau spesialis memiliki kode tertentu untuk membedakan klinik atau spesialis satu dengan yang lain?
17. Ada berapa banyak dokter yang bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah?
18. Apakah dokter yang bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah ini memiliki id dokter?
19. Apakah semua dokter yang bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah memiliki hari kerja yang sama (Senin s/d Minggu)?
20. Bagaimana sistematika pembagian jadwal praktek dokter di Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah?

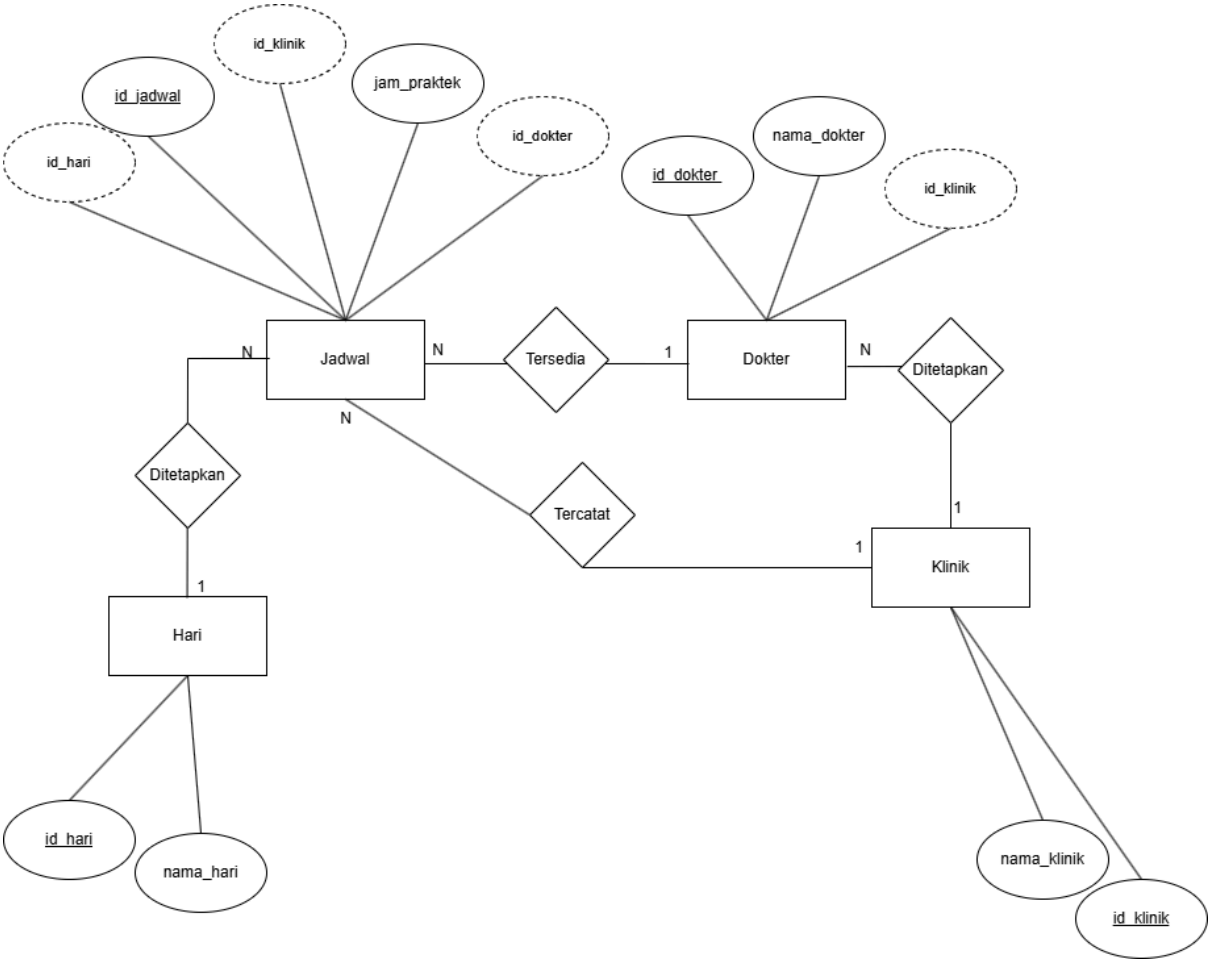
21. Apakah dalam jam praktek dokter di Rumah Sakit Pondok Indah menerapkan sistem sesi atau jam bebas?
22. Dari jadwal praktek dokter yang telah diberikan, di bagian dokter umum, spesialis radiologi gigi, spesialis radiologi, dan spesialis anestesi sebagian besar dokter tidak memiliki jadwal praktek, apakah dokter-dokter tersebut memang tidak ada jadwal praktek di Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah, atau bagaimana?
23. Jika ada situasi dimana ada Dokter A dan Dokter B dan kedua dokter ini memiliki jadwal praktik yang sama, pasien ingin berkonsultasi dengan Dokter A, tetapi pada saat pasien sudah sampai, ternyata Dokter A berhalangan hadir, apakah si pasien dapat meminta ke pihak Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah untuk berpindah dokter pada saat itu juga sehingga dapat ikut ke antrian konsultasi dengan Dokter B atau tidak bisa?
24. Bagaimana proses pengelolaan data dokter, jadwal, dan hari dilakukan?
25. Bagaimana cara sistem Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah dalam membuat janji temu antara pasien dan dokter yang jadwal prakteknya memang berdasarkan janji temu yang telah dibuat?

3.4. Analisis Permasalahan

1. Kesulitan Pengguna dalam Mengoperasikan Sistem Digital: Tidak semua pengguna sistem memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk memanfaatkan fitur-fitur sistem digital secara optimal. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan input data atau waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas.
2. Keterlambatan Pembaruan Data Real-Time: Meski sistem sudah berbasis digital, pembaruan data secara real-time terkadang terganggu, terutama saat ada perubahan jadwal mendadak dari dokter. Ini dapat berdampak pada ketidakakuratan informasi yang diterima pasien dan staf rumah sakit.

BAB IV
RANCANGAN DATABASE

4.1. Entity Relationship Diagram



Gambar 4.1 ERD Jadwal Praktek Dokter Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah

4.2. Struktur Tabel

Tabel Dokter

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
☐	1	**id_dokter**	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More
☐	2	**nama_dokter**	varchar(80)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More
☐	3	**id_klinik**	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More

Gambar 4.2 Struktur Tabel Dokter

Tabel Hari

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id_hari**	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
2	**nama_hari**	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More

Gambar 4.3 Struktur Tabel Hari

Table Jadwal

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id_jadwal**	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
2	**id_klinik**	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**id_dokter**	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
4	**id_hari**	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
5	**jam_praktek**	varchar(9)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More

Gambar 4.4 Struktur Tabel Jadwal

Table Klinik

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id_klinik**	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More
2	**nama_klinik**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		No	*None*			Change Drop More

Gambar 4.5 Struktur Tabel Klinik

4.3. Query SQL

Table Dokter

```
CREATE TABLE `dokter` (
  `id_dokter` varchar(15) NOT NULL,
  `nama_dokter` varchar(80) NOT NULL,
  `id_klinik` varchar(15) NOT NULL
)
```

Gambar 4.6 Query SQL Tabel Dokter

Table Hari

```
1 CREATE TABLE `hari` (
2   `id_hari` varchar(15) NOT NULL,
3   `nama_hari` varchar(30) NOT NULL
4 )
```

Gambar 4.7 Query SQL Tabel Hari

Table Jadwal

```
1 CREATE TABLE `jadwal` (
2   `id_jadwal` varchar(15) NOT NULL,
3   `id_klinik` varchar(15) NOT NULL,
4   `id_dokter` varchar(15) NOT NULL,
5   `id_hari` varchar(15) NOT NULL,
6   `jam_praktek` varchar(9) NOT NULL
7 )
```

Gambar 4.8 Query SQL Tabel Jadwal

Table Klinik

```
1 CREATE TABLE `klinik` (
2   `id_klinik` varchar(15) NOT NULL,
3   `nama_klinik` varchar(50) NOT NULL
4 )
```

Gambar 4.9 Query SQL Tabel Klinik

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah, didapatkan solusi untuk mengoptimalkan sistem digital dengan memberikan pelatihan kepada pengguna agar lebih memahami fitur-fitur sistem serta memastikan pembaruan data dilakukan secara real-time. Dengan langkah ini, data jadwal praktek dokter dapat tersimpan secara terstruktur, diakses dengan cepat, dan selalu akurat. Relasi antar data dalam sistem juga telah dirancang agar mendukung integrasi lintas departemen dengan baik.

5.2. Penutup

Laporan ini telah menjelaskan pengelolaan database jadwal praktek dokter di Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah dengan jelas dan ringkas. Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat untuk semua yang hadir. Kami terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Armoni, A. (2002). *Healthcare Information Systems: Challenges of the New Millennium*. Idea Group Publishing.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Benson, T., & Grieve, G. (2016). *Principles of Health Interoperability: SNOMED CT, HL7, and FHIR* (3rd ed.). Springer.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (15th ed.). Pearson.

Wager, K. A., Lee, F. W., & Glaser, J. P. (2017). *Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management* (4th ed.). Jossey-Bass.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Rumah Sakit Pondok Indah Group……7
Gambar 3.2 Bangunan Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah……8
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah……...10
Gambar 4.1 ERD Jadwal Praktek Dokter Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah…….13
Gambar 4.2 Struktur Tabel Dokter…….....13
Gambar 4.3 Struktur Tabel Hari…….14
Gambar 4.4 Struktur Tabel Jadwal…….14
Gambar 4.5 Struktur Tabel Klinik……..14
Gambar 4.6 Query SQL Tabel Dokter……14
Gambar 4.7 Query SQL Tabel Hari……15
Gambar 4.8 Query SQL Tabel Jadwal……....15
Gambar 4.9 Query SQL Tabel Klinik……..…15